EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 81709
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-04-01 15:20:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARGARITA DE LAS MER HERRERA CIFUENTES			**RUN**	: 11.447.235-2
F.Nac	: 05-08-1969	**Edad**	: 54 AÑOS, 7 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: PJE. LUIS ARANEDA # 24 VILLA SANTA MARIA			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 66140917		
Fecha Ingreso	: 2024-03-21	**Fecha Egreso**	: 2024-04-01 15:20:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. K65.9-PERITONITIS, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

Epicrisis a Hodom.

Diagnosticos:

-Peritonitis Espondanea Sospecha Secundaria, fuera del alcance quirurgico
-SHR tipo II , no candidata a TSR
-Cirrosis OH CHILD C en etapa terminal, no candidata a trasplante - en cuidados paliativos.
-Ascitis Intratable/Refractaria a diureticos
-ERC Etapa V
-Hipoacusia severa

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. K70.3-CIRROSIS HEPATICA ALCOHOLICA. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Ingresa por dolor abdominal generalizado. Parametros inflamatorios bajos.Se realiza paracentesis diagnostica en servicio de urgencias con elevada cantida de GB 4920 con glucosa 97 y cultivo positivo para E Coli MS.
Se inicia manejo con ceftriaxona sin embargo debido a gran ascitis se dedcide nuevmaante realizar apracentesis pero esta vez evacuadora, se realiza paracentesis ecoguiada en el servicio de medicina con salida de liquido hematico por lo que se suspende procedimiento luego de extraer 5cc. Se establece manejo exclusivamente medico con antibioticos y si no hay respuesta no se escalará en medidas.

Con elevacion paulatina de parametros inflamatorios que responden parcialmente al tratamietno antibiotico. Dolor abdominal a la baja ultimos dias y parametros inflamatorios estacionarios.

Debido al alto conteo de GB se sospecha de Peritonitis secundaria , evaluado por Dr Jara quien indica que paciente debido a patologias de base y en etapa terminal de su enfermedad se encuentra fuera del alcance quirurgico.

Dentro de su enfermedad de base se encuentra sin variacion significativa por lo que no es un conflicto actualmente.

Al dia 1.4.24 se encuentr afebril , normocardica, sin necesidades de oxigeno , normotensa.

Laboratorio
PCR 172 (estacionaria) llegó hasta 250
crea 9.5 / Na 129 / K 5.4 / CL 103
Proca 3.02
GB 3900 / PL 71.000 / HB 8.3

PLAN DE MANEJO:

Del punto de vista medico y quirurgico paciente no tiene posibilidad de resolucion de sus patologias ya que se sospecha de patologia quirurgica que es imposible solucionar debido a condicion basal de la paciente, sellando asi su pronostico.
Como alternativa está el mantenimiento de tratamiento antibiotico a permanencia con posibilidad de controlde carga bacteriana y asi prolongar sobrevida.
Se indica traslado a Hodom y manejo en conjunto con cuidados paliativos (como ya se estaba realizando) con el fin de mantener manejo con ceftriaxona y paracentesis evacuadoras seriadas en caso que lo requiera. Si existe mala evolucion clinica se iniciará manejo con analgesia opioide y cuidados de fin de vida por imposibilidad de resolver patologia actual.

INDICACIONES AL ALTA

1. Indicaciones al alta.
2. -Regimen papilla asistido
3. -Reposo relativo
4. -Lactulosa 20cc/ via oral c/8horas
5. -Propanolol 20mg via oral una vez al dia
6. -Espironolactona 25mg al dia vo
7. -Metamizol 1 compromido cada 8 horas
8. -Bicarbonato de sodio 1g vo cada 12 horas
9. -Tramadol 5 gotas c 12h vo SOS
10. -Furosemida 40mg vo una vez al dia
11. -Ceftriaxona 2g ev por 5 dias mas, luego Cefadroxilo 1g vo cada 12 horas a permanencia.
12. -Si hay mala evolucion de patologia actual , analgesia opioide parenteral y cuidados de fin de vida.

Jorge Andres Villa Flores
MEDICO TRATANTE
16178692-6

JEFE SERVICIO